

CHƯƠNG 7: UNG THƯ

SỐT GIẢM BẠCH CẦU HẠT Ở TRẺ EM UNG THƯ

ThS.Trần Thu Hà

1. ĐẠI CƯƠNG

Trẻ em bị các bệnh ung thư được điều trị bằng các chế độ tăng cường (hoà trị liệu liều cao, tia xạ, ghép tuỷ xương) thường bị suy giảm miễn dịch và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Nhiễm trùng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em bị ung thư. Sốt giảm bạch cầu hạt là một cấp cứu. Việc áp dụng ngay tức thì liệu pháp kháng sinh kinh nghiệm cho bệnh nhân sốt giảm bạch cầu hạt đã giảm tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn Gram âm từ 80% xuống còn 10%.

2. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN

- Sốt: nhiệt độ $\geq 38,3^{\circ}\text{C}$ một lần hoặc $38^{\circ}\text{C} - 38,2^{\circ}\text{C}$ kéo dài trên 1 giờ hoặc 2 lần trong vòng 24 h, cách nhau ít nhất 12 giờ. (Nhiệt độ được đo ở miệng hoặc đầu dò màng nhĩ).

- Giảm bạch cầu hạt: BC hạt $< 500/\text{mm}^3$ hoặc $< 1000/\text{mm}^3$ nhưng dự đoán sẽ giảm tiếp trong 2 ngày tới $< 500/\text{mm}^3$. Giảm bạch cầu hạt nặng: BC hạt $< 100/\text{mm}^3$.

3. CÁC TÁC NHÂN THƯỜNG GẶP NHẤT

- Vi khuẩn Gram dương: *Staphylococci* (*S.aeruginosa*, *S.epidermidis*), *Streptococci* (α - hemolytic; nhóm D) *Corynebacterium*, *Listeria*, *Clostridium difficile*

- Vi khuẩn Gram âm: *Enterobacteriaceae* (*E. Coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*), *Pseudomonads* (kháng đa KS), *Anaerobes* (*Bacteroides*).

- Nấm: *Candida*, *Aspergillus*, *Phycomycete*, *Cryptococcus*.

- Virus: *Herpes simplex*, *Varricella Zoster*, *Cytomegalovirus*, *Epstein – Barr*, *Respiratory syncytial*, *Adenovirus*, *Adenovirus*, *Influenza*, *Rotavirus*
- Nguyên nhân khác: *Pneumocystis carinii*, *Toxoplasma gondii*, *Cryptosporidia*

4. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ

- Bệnh ác tính: u lympho, bạch cầu cấp...
- Hóa trị liệu, steroid, phẫu thuật, dụng cụ nội mạch, sonde tiểu...

5. LÂM SÀNG

- Hỏi bệnh sử và khám lâm sàng tỉ mỉ, đặc biệt chú ý tới những vị trí hay bị nhiễm trùng ở bệnh nhân sốt giảm bạch cầu hạt.
- Các dấu hiệu sinh tồn.
- Da, đầu vào và đường đi của catheter trung tâm: viêm tấy, có mủ.
- Khó thở và các biểu hiện suy hô hấp.
- Niêm mạc miệng và vùng quanh miệng: viêm loét, hoại tử.
- Vùng quanh hậu môn: viêm hoặc nứt kẽ.
- Khám bụng, phản ứng thành bụng.
- Các dấu hiệu nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương.

6. CẬN LÂM SÀNG

Với bệnh nhân sốt giảm bạch cầu hạt, một viêm nhiễm nhẹ, kín đáo cũng có thể là nguồn gốc nhiễm trùng vì vậy cần phải được cấy tìm vi khuẩn. 10-30% bệnh nhân sốt giảm bạch cầu hạt có kết quả cấy vi khuẩn dương tính.

- Tổng phân tích máu ngoại vi - độ tập trung tiểu cầu.
- Cấy máu 2 mẫu: 1 mẫu catheter trung tâm và 1 mẫu máu ngoại vi hoặc 2 mẫu máu ngoại vi ở 2 vị trí khác nhau, hoặc cùng 1 vị trí, cách nhau > 20 phút.
- Các xét nghiệm chẩn đoán khác phụ thuộc vào biểu hiện lâm sàng:

- + Cây nước tiểu và tổng phân tích nước tiểu; soi phân, cấy phân, cấy mủ.
- + Soi, cấy đờm; soi tươi, PCR dịch rửa PQ chẩn đoán *Pneumocystis carinii*.
- + X quang tim phổi, CT lồng ngực; siêu âm, chụp X quang, CT bụng nếu nghi ngờ viêm phúc mạc, viêm ruột thừa, viêm hồi manh tràng; siêu âm tim...
- CRP và/hoặc procalcitonin, điện giải đồ, Ca, urê, creatinin, men gan...

7. ĐIỀU TRỊ

7.1. Nguyên tắc: Liệu pháp kháng sinh phổ rộng kinh nghiệm càng sớm càng tốt.

- Liệu pháp KS kinh nghiệm: một KS nhóm β -lactam có tác dụng với trực khuẩn mủ xanh đơn thuần hoặc kết hợp aminoglycoside (tobramycin, amikacin).

- Khi chọn liệu pháp kinh nghiệm cần cân nhắc loại vi khuẩn thường gặp, mô hình kháng KS ở địa phương, tiền sử dị ứng thuốc...lựa chọn ban đầu có thể là:

- + Piperacillin- tazobactam hoặc.
- + Cefoperazon, ceftazidime, cefepim hoặc.
- + Carbapenem (imipenem-cilastatin hoặc meropenem): nếu sốt cao liên tục, rét run, giảm BC hạt nặng.
- Bệnh nhân dị ứng với penicillin nên được điều trị kết hợp ciprofloxacin và clindamycin hoặc aztreonam và vancomycin(tránh β -lactam và carbapenem).

Liệu pháp kháng sinh ban đầu có thể điều chỉnh như sau

▪ Cây máu dương tính Methicillin-resistant <i>S. aureus</i> <i>Enterococcus</i> kháng vancomycin VK Gr(-) tiết β- lactamase phổ rộng VK tiết carbapenemase	▪ Kháng sinh theo kháng sinh đồ Kết hợp vancomycin, linezolid hoặc daptomycin. Kết hợp linezolid hoặc daptomycin. Cân nhắc dùng carbapenem Polymyxin – colistin hoặc tigecycline
▪ Nhiễm khuẩn Catheter, đa hoá trị liệu tích cực gây tổn thương niêm mạc miệng nặng, nhiễm trùng da và mô mềm, viêm phổi, tổn thương sùi ở van tim hoặc huyết động không ổn định. ▪ Viêm niêm mạc miệng nặng, nứt kẽ hậu môn hoặc có dấu hiệu nặng ở bụng (phản ứng thành bụng...) ▪ Viêm phổi lan toả ▪ Tổn thương hình tròn ở phổi hoặc thâm nhiễm phổi mới ▪ Không đỡ sốt sau 2 – 3 ngày ▪ Nếu sốt dai dẳng 4 – 7 ngày hoặc tái phát	▪ Vancomycin, ngừng vancomycin nếu cây máu âm tính với vi khuẩn Gr(+) ▪ Metronidazol điều trị vi khuẩn kỵ khí ▪ Co-trimoxazole và azithromycin ▪ Kết hợp amphotericin B ▪ Cân nhắc đổi KS kinh nghiệm ▪ Bắt đầu kháng sinh chống nấm amphotericin B

6.2. Điều trị sốt không rõ nguyên nhân

- Nhiều bệnh nhân sốt giảm bạch cầu hạt không xác định được nguyên nhân sốt. Trong số này có một tỷ lệ đáng kể có nhiễm trùng sâu kín.

- Sốt không rõ nguyên nhân được chia làm 2 nhóm:

+ Nguy cơ thấp: bạch cầu hạt hồi phục trong vòng 1 tuần và không có hoặc ít bệnh lý kết hợp → điều trị kháng sinh kinh nghiệm → ngừng kháng sinh khi bạch cầu hạt đạt $500/\text{mm}^3$ trong 2 ngày liên tiếp.

+ Nguy cơ cao: Giảm bạch cầu hạt kéo dài hơn 1 tuần và không có bằng chứng hồi phục tủy xương sau hóa chất độc tế bào và/hoặc tình trạng bệnh kết hợp quan trọng như hạ huyết áp, viêm phổi, đau bụng, thay đổi tinh thần, hoặc hết sốt nhưng có các triệu chứng, dấu hiệu nhiễm trùng mới → điều trị một đợt kháng sinh 14 ngày và ngừng nếu hết sốt, nếu sốt lại → tiếp tục điều trị kháng sinh và kết hợp thuốc chống nấm.

6.3. Liệu pháp chống nấm

- Bệnh nhân giảm bạch cầu hạt sốt dai dẳng sau 4 – 7 ngày điều trị bằng kháng sinh phổ rộng nên được điều trị bằng liệu pháp chống nấm toàn thân.

- Fluconazole uống hoặc tiêm TM được lựa chọn theo kinh nghiệm với những bệnh nhân giảm bạch cầu hạt, sốt dai dẳng.

- Amphotericin B được chỉ định với bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm nấm cao hoặc cấy máu dương tính với nấm. Khi sử dụng amphotericin B cần theo dõi BUN, creatinin, điện giải đồ hàng ngày vì amphotericin B gây độc với thận và làm giảm Na^+ và K^+ máu nặng. Nếu creatinin tăng 1,5 – 2 lần so với bình thường, có thể phải ngừng thuốc và thay bằng chế phẩm amphotericin B tan trong lipid.

6.4. Điều trị kết hợp

- BN nhiễm khuẩn hoặc sốt giảm BC hạt nặng: G – CSF 5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{ngày}$ (không chỉ định cho BN bạch cầu cấp đang điều trị giai đoạn tấn công).

- Truyền máu và các chế phẩm nếu thiếu máu ($\text{Hb} < 80 \text{ g/L}$), xuất huyết, $\text{TC} < 20.000/\text{mm}^3$ hoặc rối loạn yếu tố đông máu.

- Viêm loét niêm mạc miệng:

+ Súc, lau miệng bằng natriclorua 9‰, dd natribicarbonate 14‰, chlorhexidine 0,2%. Nếu viêm loét nặng nên súc miệng bằng ôxy già pha loãng 1/8 với nước sạch hoặc natriclorua 9‰.

+ Thuốc chống nấm: nystatin hoặc daktarin dạng bột hoặc kem bôi miệng.

+ Viêm loét nặng kèm các nốt phỏng coi như sự hoạt hóa HSV: acyclovir .

+ Giảm đau tại chỗ: cepacaine súc miệng, bôi xylocain gel trước khi ăn.

+ Giảm đau toàn thân (panadol, codeine hoặc morphine) được chỉ định theo mức độ đau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA et al (2011), Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA Guideline), *Clinical Infectious Diseases*, 52(4): 427- 431
2. Mendes AVA, Sapolnik R, Mendonça N (2007), New guidelines for the clinical management of febrile neutropenia and sepsis in pediatric oncology patients, *J Pediatr (Rio J)*, 83(2 Suppl): S54-63
3. National Comprehensive Cancer Network (2018), Prevention and treatment of cancer-related infections , NCCN Guideline Version 1.2018: 16-40
4. Peter G. Pappas,¹ Carol A. Kauffman,² and et al (2016), Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA Guidelines), *Clinical Infectious Diseases*, 62: 1-50
5. Philip Lanzkowsky (2000), Management of Infectious Complications, *Manual of Pediatric Hematology and Oncology*, 3rd Edition, : 677 – 691

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SUY TỦY XƯƠNG MẮC PHẢI

PGS.TS. Bùi Văn Viên

TS. Nguyễn Thị Hương Mai

1. ĐẠI CƯƠNG

Suy tủy xương (STX) là tình trạng bệnh lý của tế bào gốc tạo máu gây ra hậu quả tủy xương không sản sinh được đầy đủ các dòng tế bào dẫn đến giảm hồng cầu, bạch cầu, và tiểu cầu ở máu ngoại biên. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh (20%) hoặc mắc phải (80%). STX mắc phải có thể tìm được nguyên nhân như tia xạ, hóa chất, virus... hoặc không rõ nguyên nhân chiếm 60-70% trường hợp. Cho đến nay cơ chế bệnh sinh STX mắc phải còn nhiều tranh cãi, nhưng đa số các nghiên cứu cho rằng đây là bệnh tự miễn dịch. Dựa trên giả thuyết này, hai phương pháp điều trị bệnh STX mắc phải được sử dụng nhiều nhất hiện nay là thuốc UCMD và ghép TBG đồng loại. Trong phạm vi bài này chúng tôi giới thiệu phác đồ điều trị STX toàn bộ mắc phải.

2. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

2.1. Lâm sàng

- Thiếu máu xảy ra từ từ, ngày càng nặng và khó hồi phục bằng truyền máu.
- Mức độ thiếu máu nặng hơn mức độ xuất huyết.
- Xuất huyết do giảm tiểu cầu.
- Có thể sốt và nhiễm khuẩn.
- Không có gan lách hạch to.
- Không có dị dạng cơ thể

2.2. Huyết đồ

Cần ít nhất 2/3 tiêu chuẩn sau: Hb < 100g/l, TC < 50 G/l, BCTT < 1,5 G/l

2.3. Tủy đồ

Có số lượng tế bào tủy giảm. Các dòng HC, BC hạt và mẫu TC giảm. Hoặc Sinh thiết tủy thấy tủy mỡ hóa và nghèo tế bào.

3. XÉT NGHIỆM THĂM DÒ KHÁC TÌM NGUYÊN NHÂN

- Phân tích chromosome: test đứt gãy chromosome loại trừ Fanconi
- Flow cytometry (CD55, CD59) tìm nguyên nhân Huyết sắc tố niệu kịch phát về đêm (PNH).
- Chức năng gan thận.
- Virus: viêm gan A, B và C, EBV, CMV, Parvo virus B19.
- Xét nghiệm đánh giá các bệnh tự miễn: kháng thể kháng nhân, kháng thể kháng DNA.
- CD3, CD4 và CD8.

4. PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ NẶNG STX THEO CAMITTA 1976

- Nặng: Số lượng tế bào tủy xương < 30 G/l. Máu ngoại vi có 2/3 tiêu chuẩn sau: BCTT < 0,5G/l, TC < 20G/l, HCL < 20 G/l.
- Rất nặng: Như suy tủy nặng nhưng BCTT < 0,2G/l.
- Không nặng: không đủ tiêu chuẩn suy tủy nặng/ rất nặng trên.

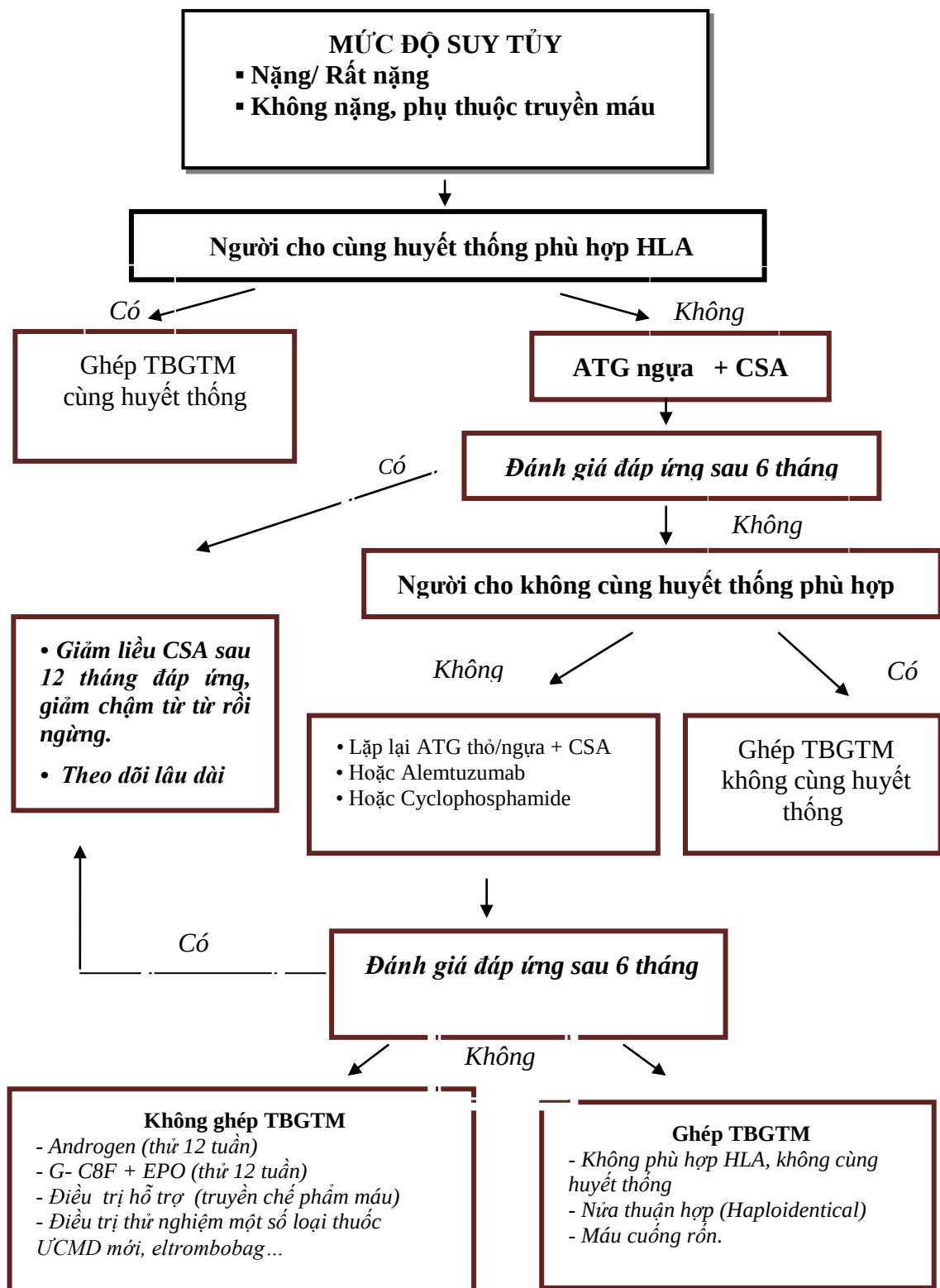
Lưu ý: Bệnh nhân STX nặng/rất nặng đều phụ thuộc truyền máu. Bệnh nhân STX không nặng có thể phụ thuộc hay không phụ thuộc truyền máu.

5. ĐIỀU TRỊ

5.1. Điều trị đặc hiệu

5.1.1. Nguyên tắc điều trị

- Suy tủy không nặng:
 - + Theo dõi sát và điều trị hỗ trợ.
 - + Nếu phát triển STX nặng hoặc không nặng nhưng phụ thuộc truyền máu thì điều trị như STX nặng.
- Suy tủy nặng / rất nặng: Cần phải tiến hành điều trị đặc hiệu càng sớm càng tốt. Trình tự ưu tiên lựa chọn phác đồ điều trị như sơ đồ dưới đây:



5.1.2. Phương pháp ức chế miễn dịch bằng ATG và CSA

(1) ATG (Thymogram) 40 mg/kg/ngày, pha với dung dịch NaCl 0,9% (đảm bảo nồng độ < 4mg/ml) truyền tĩnh mạch trong 5 ngày từ ngày 1-5. Thử phản ứng bằng cách tiêm máy chậm 10- 20 ml/h, sau đó nếu không có phản ứng tăng tốc độ truyền, liên tục 8 – 12 giờ/ngày.

(2) CSA 6mg/kg/ngày, chia làm 2 lần cách nhau 12h từ ngày 1. Kiểm tra nồng độ CSA 72h sau khi dùng liều CSA đầu tiên. Duy trì nồng độ CSA huyết thanh 100-150 ng/ml. CSA cần dùng liên tục trong 6-12 tháng để đánh giá đáp ứng, có thể ngừng thuốc sau đó nếu không có đáp ứng điều trị. Nếu bệnh nhân có đáp ứng, thì sau 12 tháng tính từ khi bắt đầu có đáp ứng sẽ giảm dần liều dần mỗi 25mg/1-2 tháng rồi mới ngừng hẳn, để giảm nguy cơ tái phát STX.

(3) Pipolphen 0,5 – 1 mg/kg, tĩnh mạch chậm 30 phút ($\times$ 3 lần/ngày) + Solumedrol 1-2 mg/kg, tĩnh mạch ($\times$ 2 lần/ngày) + Paracetamol 10-15 mg/kg uống ($\times$ 3 lần/ngày) để phòng bệnh huyết thanh, liều đầu tiên trong ngày dùng trước khi truyền ATG 1 h, cho trong 5 ngày. Sau đó tiếp tục prednisolon uống ngày 6-14, giảm liều dần và ngưng trong 2 tuần.

(4) G-CSF 5 μ g/kg/ngày tiêm dưới da khi BC hạt < 0,5 G/l, đến khi BC hạt >1 G/l thì dừng.

(5) Biseptol cho liều 5 mg/kg/ngày trimethoprim, chia 2 lần, cách nhật + Levofloxacin(Ciprobay) 500 mg/ngày + Fluconazol 3-5 mg/kg/ngày để dự phòng nhiễm Pneumocystis carinii, vi khuẩn và nấm, cho đến ngày 21.

Sau 6 tháng kể từ ngày 1 của ATG, nếu đánh giá bệnh nhân không đáp ứng sẽ có chỉ định dùng ATG đợt 2 tương tự (ngừa/thở).

5.2. Điều trị hỗ trợ

- Chống thiếu máu: truyền KHC để duy trì lượng Hb >80 g/L.
- Phòng chảy máu các bộ phận nguy hiểm: Chỉ định truyền KTC khi TC < 10 G/l nếu không sốt hoặc khi TC < 20G/l nếu có sốt.

- Lưu ý: không nên truyền máu toàn phần mà chỉ truyền thành phần bệnh nhân thiếu như KHC, KTC hay plasma.

- Trong trường hợp có điều kiện ghép tủy, để tránh bệnh mảnh ghép chống vật chủ cần tránh truyền máu của người cho là cha mẹ, anh em, hay người có quan hệ họ hàng với bệnh nhi. Chú ý là tất cả các chế phẩm máu ở trên đều phải được lọc bạch cầu.

- Đề phòng nhiễm khuẩn:

+ Vệ sinh cá nhân, chăm sóc răng miệng, không cấp nhiệt độ ở hậu môn, không để chấn thương da và niêm mạc.

+ Nếu có sốt cần tìm ổ nhiễm khuẩn, cấy các dịch, cho kháng sinh phổ rộng, liều cao.

6. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG

6.1. Theo dõi

- Tổng phân tích tế bào máu, Hồng cầu lưới.

- Chức năng gan-thận.

- Nồng độ CSA.

- CD3, CD4, CD8, tỉ lệ CD4/CD8.

- Làm các xét nghiệm trên các thời điểm 1 tuần, 2 tuần, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm. Riêng CSA cứ 1 tuần/lần hay khi có thay đổi về liều trong tháng đầu sau đó 1 tháng/lần.

6.2. Đánh giá đáp ứng

Thường đáp ứng xảy ra sau 3-4 tháng dùng ATG.

6.2.1. Tiêu chuẩn đáp ứng với ATG của suy tủy nặng

- Không đáp ứng: vẫn nặng.

- Đáp ứng một phần: bệnh nhân không phụ thuộc truyền máu nữa.

- Đáp ứng hoàn toàn: Hb về bình thường so với tuổi, BCTT > 1,5 G/l, TC > 150 G/l.

6.2.2. Tiêu chuẩn đáp ứng đối suy tủy không nặng

- Không đáp ứng: xấu đi hay không đạt các tiêu chuẩn đáp ứng hoàn toàn hay một phần dưới đây.

- Đáp ứng một phần:

+ Không phụ thuộc truyền máu (trước đây phụ thuộc truyền máu).

+ Hoặc tăng gấp đôi hay đạt bình thường ít nhất một dòng tế bào.

+ Hoặc tăng Hb cơ bản $> 30 \text{ g/l}$ (nếu lúc đầu < 60).

+ Hoặc tăng ANC cơ bản $> 0,5 \text{ G/l}$ (nếu lúc đầu $< 0,5$).

+ Hoặc tăng tiểu cầu cơ bản $> 20 \text{ G/l}$ (nếu lúc đầu < 20).

+ Đáp ứng hoàn toàn: tiêu chuẩn như suy tủy nặng ở trên.

7. THEO DÕI LÂU DÀI SAU ĐIỀU TRỊ ATG VÀ CSA

- Tất cả các bệnh nhân đáp ứng điều trị nên được theo dõi các biến chứng muộn như tái phát (25 - 40%) hoặc chuyển biến cụm tế bào thành các bệnh lý huyết học khác bao gồm PNH, MDS hay AML (10-15 %).

- Theo dõi các triệu chứng thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng xuất hiện trở lại và các xét nghiệm sau:

+ Tổng phân tích tế bào máu, hồng cầu lưới.

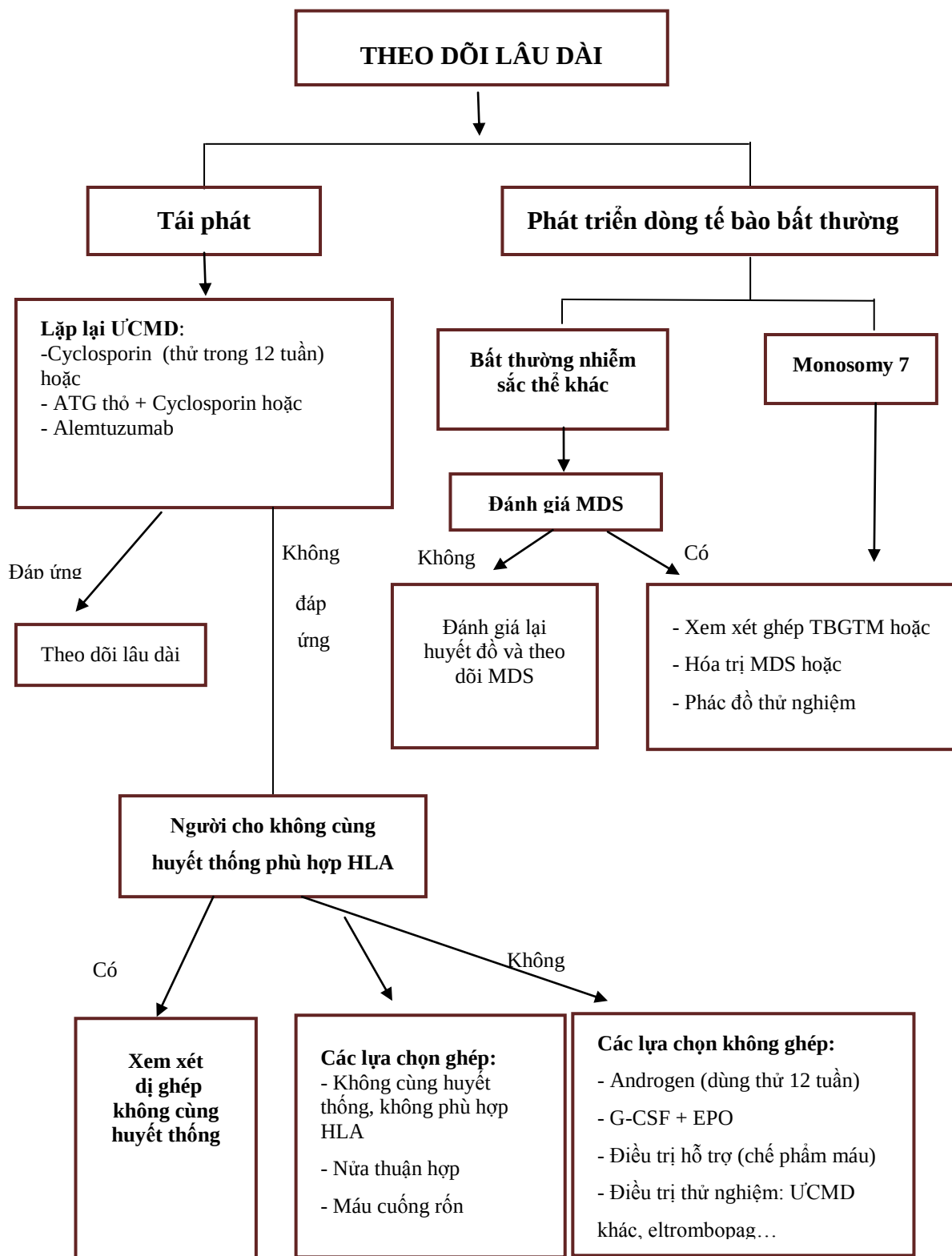
+ Tủy đồ, sinh thiết tủy (nếu có giảm tế bào máu): đánh giá xuất hiện STX tái phát hay MDS/AML.

+ Phân tích di truyền tế bào dịch tủy xương: tìm bất thường monosomy 7 hay các bất thường NST khác trong MDS.

+ Flow cytometry: tìm thiếu hụt CD55, CD59 trong PNH.

- Các xét nghiệm trên làm vào các thời điểm 6 tháng, 1 năm, sau đó hàng năm.

Phác đồ điều trị tiếp nếu có tái phát hoặc chuyển biến cụm tế bào như sơ đồ sau:



Sơ đồ theo dõi lâu dài STX sau điều trị ATG + CSA

4. Wolfe L. General approach to diagnosis of hemolytic anemia (2011). In: Philip Lanzkowsky (ed). Manual of Pediatric Hematology and Oncology. pp 172-199
5. Zanella.A, Barcellini . W(2014). Treatment of autoimmune hemolytic anemias. Haematologica;99(10).

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THỰC BÀO TẾ BÀO MÁU (HLH)

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

1. ĐẠI CƯƠNG

HLH (Hemophagocytic lymphohistocytosis) là một nhóm các rối loạn biểu hiện chung là sự tăng sinh bất thường và gia tăng hoạt tính tiêu hủy các tế bào máu của các đại thực bào Histocytes. HLH được đặc trưng bởi tình trạng viêm đa hệ thống.

Kết quả của bệnh nhân điều trị theo phác đồ HLH – 94 ở 113 bệnh nhân dưới 15 tuổi từ 21 nước trên thế giới có tỷ lệ sống toàn bộ (overall survival) 5 năm là 55%. Năm 1999, đột biến gen 10q21 được tìm thấy có liên quan đến bệnh nhân HLH thể gia đình. Năm 2003, người ta phát hiện ra đột biến hMunc 13 – 4 (17q25). Trong hội chứng liên quan đến nhiễm sắc thể X (XLP), 60 - 70% bệnh nhân có đột biến gen SAP hoặc DSHP.

2. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Trong HLH, các triệu chứng lâm sàng xuất hiện là do nồng độ cao và kéo dài của các yếu tố cytokin bị kích hoạt không kiểm soát được từ tế bào lympho T và NK, đại thực bào lưu hành trong hệ tuần hoàn. Gần đây, phân tích về gen đã cho thấy tăng cao IL1b, TNF α , IL - 6, IL - 8 chính điều này đã làm cho cơ

thể không kiểm soát được hoạt động của tế bào histiocyte, lympho T và làm rối loạn chức năng tiến triển của các cơ quan, tổ chức.

3. PHÂN LOẠI

- Thể tiên phát hay HLH thể gia đình (Familial HLH). Đây là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường. Khoảng 20 - 40% trẻ mắc HLH ở thể này. Mặc dù có tên là FHL nhưng thường không có tiền sử gia đình. Tỷ lệ mắc phải ở Thụy Điển là 1.2/1 triệu trẻ/năm (khoảng 1:50.000 trẻ sống). FHL là một bệnh gây tử vong cao nếu không được điều trị trong vòng khoảng 2 tháng sau khi chẩn đoán. Ở Pháp, khoảng 85% trẻ mắc thể FHL là dưới 2 tuổi.

- Thể thứ phát hay HLH mắc phải: thể này có biểu hiện của hội chứng hoạt động của đại thực bào với biểu hiện thực bào máu, đây là kết quả của hoạt động miễn dịch quá mức của hệ thống thực bào đơn nhân xảy ra sau hay phối hợp với một số bệnh lý nhiễm trùng nặng như nhiễm EBV, CMV, Ecoli, kí sinh trùng, nấm,... và bệnh bạch cầu cấp, u lympho, lupus ban đỏ.

4. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN

Biểu hiện lâm sàng của HLH là sốt, gan lách to và giảm các dòng tế bào máu. Những dấu hiệu khác bao gồm tăng triglycerit, giảm fibrinogen, tăng ferritin, rối loạn chức năng gan. Triệu chứng thần kinh có thể gặp bằng biểu hiện tăng protein dịch não tủy. Ngoài ra bệnh HLH còn có các biểu hiện khác như hạch to, ban đỏ ở da, vàng da và phù.

4.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán năm 2004: Chẩn đoán xác định là HLH khi có 1 hoặc 2 điều kiện sau

- Chẩn đoán phân tử khẳng định là HLH.
- Chẩn đoán là HLH khi có ít nhất 5 trong 8 tiêu chuẩn dưới đây:
- Chẩn đoán ban đầu dựa vào lâm sàng:
 - + Sốt.

+ Lách to.

+ Giảm ít nhất 2 trong 3 dòng máu ngoại biên: Hb < 90 g/L; Tiểu cầu < 100 G/L; Bạch cầu hạt < $1.0 \times 10^9/L$ (trẻ em < 4 tuần tuổi Hb < 100 g/L).

+ Tăng Triglyceride máu và/ hoặc giảm fibrinogen máu (triglyceride máu ≥ 3 mmol/L; fibrinogen ≤ 1.5 g/L).

+ Tuỷ đồ, lách đồ hoặc hạch đồ có thực bào tế bào máu. Không có bằng chứng của bệnh lý ác tính.

- Tiêu chuẩn chẩn đoán mới:

+ Giảm hoặc mất hoạt động của tế bào NK.

+ Ferritin ≥ 500 $\mu\text{g/L}$.

+ CD 25 hoà tan (soluble IL-2 receptor) ≥ 2400 U/mL.

4.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán HLH năm 2009

- Chẩn đoán phân tử khẳng định là HLH hoặc hội chứng thực bào tế bào máu liên quan đến nhiễm sắc thể X.

- Hoặc có ít nhất 3 trong 4 tiêu chuẩn sau:

+ Sốt.

+ Lách to.

+ Giảm ít nhất 2 dòng tế bào máu.

+ Viêm gan.

- Và ít nhất 1 trong 4 tiêu chuẩn sau:

+ Thực bào máu.

+ Ferritin tăng.

+ SL2R α tăng (tùy theo tuổi).

+ Mất hoặc giảm chức năng NK.

- Các tiêu chuẩn hỗ trợ chẩn đoán:
- + Tăng triglycerid máu.
- + Giảm fibrinogen máu.
- + Giảm Natri máu.

4.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán khi nghi ngờ bệnh nhân mắc HLH

- Dịch não tủy đục (có tế bào môn trong dịch não tủy) và/hoặc tăng protein dịch não tủy.
- Sinh thiết gan thấy có hình ảnh của viêm gan mãn tính.
- Loại trừ các bệnh lao toàn thể.
- Các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm khác: triệu chứng của não - màng não, hạch ngoại biên to, vàng da, phù, có ban trên da, men gan tăng, giảm protein máu, giảm natri máu, VLDL tăng và HDL giảm.
- Không phải tất cả các bệnh nhân đều có đầy đủ tiêu chuẩn chẩn đoán nhưng có một số bệnh nhân có thể có thêm những dấu hiệu khẳng định trong quá trình điều trị thì chúng ta phải điều trị ngay khi nghi ngờ bệnh nhân có mắc HLH.

5. ĐIỀU TRỊ

5.1. Điều trị cấp cứu

- Điều trị ban đầu kéo dài 8 tuần. Liều thuốc được tính theo diện tích da (m^2).
- Điều trị trợ giúp sớm và tích cực ngay từ đầu, sử dụng kháng sinh phổ rộng cho đến khi có kết quả cấy máu.
- IVIG 0.5g/kg cân nặng, truyền tĩnh mạch tuần 1 và tuần 4 của điều trị ban đầu.
- Dự phòng cotrimoxazole: 5 mg/kg của trimetoprim, 2- 3 lần/tuần.

- Uống thuốc chống nấm từ tuần 1 đến tuần 9.
- Cân nhắc điều trị thuốc chống virus.

5.2. Điều trị ban đầu

- Dexamethasone:

10 mg/m² trong 2 tuần đầu.

5 mg/m² trong 2 tuần tiếp theo.

2.5 mg/m² trong 2 tuần tiếp theo.

1.25 mg/m² trong 2 tuần.

- Etoposide: 150 mg/ m² x 2 lần/tuần trong 2 tuần đầu tiên. Cân nhắc nếu bệnh nhân có bạch cầu hạt < 0.5x 10⁹/L và tế bào tuỷ xương giảm nặng. Từ tuần 3- 8 truyền 1 lần/ tuần.

- Cyclosporine A (Neoral): bắt đầu với liều 6 mg/kg/ngày, chia 2 lần/ngày nếu chức năng thận bình thường. Sau đó điều chỉnh liều để đạt được nồng độ thuốc trong máu đạt khoảng 200 µg/L.

- Tiêm tuỷ sống: dịch não tuỷ được đánh giá lúc chẩn đoán và sau 2 tuần.

Nếu sau 2 tuần bệnh nhân có xuất hiện các triệu chứng thần kinh hoặc dịch não tuỷ có bất thường về protein và số lượng tế bào thì điều trị tiêm tuỷ sống 4 tuần (1 lần/ tuần). Liều thuốc được tính theo tuổi như sau:

Theo tuổi	Dưới 1 tuổi	1- 2tuổi	2- 3 tuổi	Trên 3 tuổi
Methotrexate	6 mg	8 mg	10 mg	12 mg
Prednisolone	4 mg	6 mg	8 mg	10 g

5.3. Điều trị duy trì

Tiếp tục sau điều trị ban đầu với mục đích chính là giữ cho bệnh không tiến triển từ tuần thứ 9 đến tuần thứ 40.

- Etoposide: $150\text{mg}/\text{m}^2 \times 2$ tuần/lần.
- Dexamethasone: $10\text{ mg}/\text{m}^2 \times 3$ ngày (2 tuần dùng 1 đợt).
- Cyclosporine A: duy trì liều để đạt được nồng độ thuốc trong máu khoảng $200\text{ }\mu\text{g}/\text{L}$.

6. THEO DÕI

- Đánh giá đáp ứng điều trị khi sốt giảm, lách nhỏ lại, tiểu cầu $\geq 100.000/\text{mm}^3$, fibrinogen bình thường, giảm ferritin (khoảng 25%).
- Bệnh có biểu hiện tiến triển trở lại khi tăng 3 trong các dấu hiệu sau: sốt, lách to, tiểu cầu $< 100.000/\text{mm}^3$, tăng triglycerit, Fibrinogen $\leq 1.5\text{ g/l}$, tăng ferritin, thực bào máu, CD 25 hòa tan $\geq 2400\text{ U/l}$, dấu hiệu thần kinh mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Jan- Inge (2004). Hemophagocytic Lymphohistocytosis Study Group HLH- 2004. (Phác đồ điều trị HLH- 2004).
2. Filipovich AH (2009). Hemophagocytic lymphohistocytosis (HLH) and related disorders. American Society of Hematology. 127- 131.
3. Henter JI, Horne A, Arico M et al (2007). HLH- 2004: diagnostic and therapeutic guidelines for hemophagocytic lymphohistocytosis. Pediatr blood cancer. 48: 124- 131.
2. Allen CE, Yu X, Kozinetz CA et al (2008). Highly elevated ferritin levels and diagnosis of hemophagocytic lymphohistocytosis. Pediatr Blood Cancer. 50: 1127- 1129. Abstract.

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH MÔ BÀO LANGERHAN (LCH)

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

ThS. Nguyễn Thị Hà

1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh mô bào Langerhan (LCH) hay còn gọi là bệnh tăng vồng, đây là một bệnh hiếm có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào. Bệnh do sự tăng sinh và tích lũy bất thường trong tủy xương của dòng tế bào nguồn gốc từ tế bào Langerhan. Những tế bào đuôi gai này cùng với tế bào lympho, tế bào eosin và các mô bào thâm nhiễm là đặc trưng của bệnh có thể tìm thấy ở rất nhiều cơ quan và vị trí khác nhau. Bệnh phân loại nhiều thể lâm sàng bao gồm: bệnh u hạt bạch cầu ưa xít, hội chứng Hand - Schuller - Christian hoặc bệnh Letterer- Siwe.

2. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Các tế bào LCH tích tụ trong các mô luôn ở trong trạng thái bị kích hoạt và hoạt hóa. Chúng tiết ra nhiều loại cytokin gây ra “cơn bão cytokin”. Chính các cytokin gây ra các hiện tượng xơ hóa, hoại tử nguồn gốc của toàn bộ các triệu chứng của bệnh LCH.

3. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

- Da: thường là dấu hiệu đầu tiên. Hay gặp sẩn, hồng ban, dạng tiết bã nhờn thay đổi màu sắc từ nâu tới đỏ. Vị trí hay gặp sau tai, nách, bẹn, đáy chậu. Loét nông là tổn thương thứ phát, chảy nước như eczema

- Xương: sưng đau là dấu hiệu đầu tiên thường gặp nhất ở xương sọ, sau đó là xương dài chi trên rồi đến xương dẹt (xương sườn, xương chậu, đốt sống). Sưng phần mềm xung quang xương. Lòi mắt khi tổn thương tràn ổ mắt.

- Có thể gặp viêm xương chũm. Khi tổn thương lan sang vùng tai giữa gây phá hủy các xương nhỏ dẫn tới điếc. Khi tổn thương xương hàm (gãy, đau

xương, răng lung lay, sưng lợi) biểu hiện chủ yếu sưng đau phần mềm vùng lân cận. Tổn thương đốt sống gây xẹp đốt sống.

- Gan, lách, hạch to, có thể gầy vàng da, cổ chướng do suy gan

- Thiếu máu, xuất huyết do suy tủy xương. Thường kết hợp với gan, lách to là yếu tố tiên lượng nặng.

- Tổn thương phổi: thở nhanh, co rút xương sườn là dấu hiệu đầu tiên duy nhất. Theo thời gian tăng số lượng các kén khí “phổi tổ ong” sau đó các túi khí lớn. Tràn khí màng phổi tự phát do vỡ các túi khí. Khí phế thũng, xơ hóa phổi kể là giai đoạn cuối của bệnh phổi LCH.

- Chậm tăng cân do kém hấp thu. Dấu hiệu khác như nôn, ỉa chảy (có máu hoặc không) gây ra do bệnh lý ruột do mất protein

- Đái tháo nhạt là bệnh lý nội tiết thường gặp nhất xảy ra trước, đồng thời hoặc sau các tổn thương nội sọ. Số ít bệnh nhân chậm phát triển do tổn thương tuyến yên trước và thiếu hụt hormone

- Khoảng 10% bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương thần kinh. Triệu chứng thay đổi từ mất điều hòa, loạn vận ngôn, rung giật nhãn cầu, tăng phản xạ, mờ mắt, liệt các dây thần kinh sọ.

4. CÁC XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG

- Xét nghiệm công thức máu (bạch cầu, tiểu cầu, huyết sắc tố).

- Xét nghiệm chức năng gan (GOT, GPT, γ -GT, bilirubin, protein, albumin).

- Đông máu cơ bản, tủy đồ.

- Chụp X-quang xương sọ, xương dài, xương hàm, x-quang tim phổi.

- Đo tỷ trọng nước tiểu, chức năng thận.

- MRI sọ não khi có dấu hiệu thần kinh.

- Siêu âm ổ bụng.
- Sinh thiết da, hạch, khuyết xương để chẩn đoán xác định bệnh.

5. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

Dựa vào các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả giải phẫu bệnh sinh thiết có hiện diện của kháng nguyên CD1a trên màng tế bào tổn thương hoặc tìm thấy hạt Birbeck trong tế bào tổn thương dưới kính hiển vi điện tử.

5.1. Phân loại

- Nhóm 1: bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan nguy cơ
 - + Khi có một hoặc nhiều hơn cơ quan nguy cơ như: huyết học, gan, lách, phổi.

- + Bệnh nhân với tổn thương đơn độc phổi không được chọn xếp loại

- Nhóm 2: bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan nguy cơ thấp

Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan nhưng không phải các cơ quan nguy cơ

- Nhóm 3: bệnh tổn thương xương đa ổ và khu trú vị trí đặc biệt

Bệnh nhân tổn thương xương đa ổ, tổn thương ở hai hoặc nhiều xương khác nhau. Hoặc bệnh nhân tổn thương vị trí đặc biệt như là tổn thương thần kinh trung ương với phòng mô mềm nội sọ hoặc tổn thương cột sống với phòng mô mềm trong cột sống.

6. ĐIỀU TRỊ

Hiện nay LCH vẫn đang được điều trị theo phác đồ LCH - III. Phác đồ LCH- IV vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên gần đây một số bệnh nhân cũng đã được áp dụng phác đồ LCH IV khi bị tái phát.

6.1. Nhóm 1: Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan nguy cơ

Điều trị tấn công bao gồm một hoặc hai đợt mỗi 6 tuần (tùy theo đáp ứng) và điều trị duy trì. Thời gian của toàn bộ liệu trình là 12 tháng.

6.1.1. Nhánh A

6.1.1.1. Điều trị tấn công đợt 1

- Uống prednisolon 40 mg/m² chia làm 3 lần trong 4 tuần sau đó giảm liều trong vòng 2 tuần.

- Vinblastin 6 mg/m² tiêm tĩnh mạch ngày 1 của tuần 1,2,3,4,5,6.

6.1.1.2. Điều trị tấn công đợt 2

- Bắt đầu ngay sau điều trị tấn công đợt 1 với bệnh nhân chỉ đáp ứng một phần (AD better). Bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn sau điều trị tấn công đợt 1 có thể chuyển sang điều trị duy trì.

- Prednisolon 40mg/m² uống chia làm 3 từ ngày 1-3 của các tuần từ 7-12.

- Vinblastine 6mg/m² tiêm tĩnh mạch ngày 1 của tuần 7,8,9,10,11,12.

6.1.1.3. Điều trị duy trì

- Bắt đầu điều trị duy trì từ ngày 1 của tuần 7 với bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn (NAD) sau điều trị tấn công đợt 1 hoặc từ ngày 1 của tuần 13 với bệnh nhân đáp ứng 1 phần sau điều trị tấn công đợt 2.

- 6MP uống 50mg/m² hàng ngày cho tới kết thúc 12 tháng từ khi bắt đầu điều trị.

- Prednisolon: uống 40mg/m² chia 3 lần từ ngày 1 -5 của mỗi 3 tuần, bắt đầu từ ngày 1 của tuần 7 ở bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn sau điều trị tấn công đợt 1 hoặc ngày 1 của tuần 13 ở bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn hoặc đáp ứng 1 phần sau điều trị tấn công đợt 2 cho tới kết thúc 12 tháng.

- Vinblastin: 6 mg/m² tĩnh mạch ngày 1 của mỗi 3 tuần, bắt đầu từ ngày 1 của tuần 7 ở bệnh nhân NAD sau điều trị tấn công đợt 1 hoặc ngày 1 của tuần

13 ở bệnh nhân đáp ứng 1 phần sau điều trị tấn công đợt 2 cho tới kết thúc 12 tháng.

6.1.2. Nhánh B

6.1.2.1. Điều trị tấn công đợt 1

- Prednisolon: uống 40mg/m² hàng ngày chia 3 lần trong 4 tuần, giảm liều dần trong vòng 2 tuần.

- Vinblastin: 6mg/m² tiêm tĩnh mạch ngày của các tuần 1,2,3,4,5,6 trước khi truyền Methotrexate (MTX).

- MTX: 500 mg/m² truyền tĩnh mạch 24h. Bắt đầu truyền 1/10 liều MTX trong 30 phút, sau đó 9/10 của liều truyền trong 23h30 phút cùng với 2000 ml/m² da dịch ½ Glucose+ ½ dung dịch muối sinh lý 0.9%.

- Giải độc bằng acid folinic 12 mg/m² da đường tiêm tĩnh mạch sau ngừng truyền MTX 24h và 30h.

6.1.2.2. Điều trị tấn công đợt 2

- Bắt đầu ngay sau điều trị tấn công đợt 1 với những bệnh nhân chỉ đáp ứng 1 phần. Bệnh nhân NAD sau điều trị tấn công đợt 1 chuyển sang điều trị duy trì.

- Prednisolon: uống 40 mg/m² chia 3 lần từ ngày 1-3 hàng tuần từ tuần 7-12.

- Vinblastin: 6 mg/m² ngày 1 của các tuần 7,8,9,10,11,12. Tiêm tĩnh mạch trước khi truyền MTX.

- MTX: 500 mg/m² truyền tĩnh mạch như điều trị tấn công đợt 1. Giải độc bằng axit folinic 12 mg/ m² da.

6.1.2.3. Điều trị duy trì

- 6MP uống 50mg/m² hàng ngày cho tới kết thúc 12 tháng từ khi bắt đầu điều trị.

- Prednisolon: uống 40mg/m² chia 3 lần từ ngày 1 -5 của mỗi 3 tuần, bắt đầu từ ngày 1 của tuần 7 ở bệnh nhân NAD sau điều trị tấn công đợt 1 hoặc ngày 1 của tuần 13 ở bệnh nhân đáp ứng 1 phần sau điều trị tấn công đợt 2 cho tới kết thúc 12 tháng.

- Vinblastin: 6 mg/m² tĩnh mạch ngày 1 của mỗi 3 tuần, bắt đầu từ ngày 1 của tuần 7 ở bệnh nhân NAD sau điều trị tấn công đợt 1 hoặc ngày 1 của tuần 13 ở bệnh nhân đáp ứng 1 phần sau điều trị tấn công đợt 2 cho tới kết thúc 12 tháng

- MTX: uống 20 mg/m² da, một tuần một lần cho tới kết thúc 12 tháng.

6.2. Nhóm 2: Nhóm nguy cơ thấp

Điều trị bao gồm điều trị tấn công đợt 1 kéo dài 6 tuần (điều trị tấn công đợt 2 chỉ cho những bệnh nhân bệnh tồn tại dai dẳng hoặc tiến triển) và điều trị duy trì. Toàn bộ quá trình điều trị kéo dài 6 hoặc 12 tháng.

Phác đồ tương tự nhánh A của nhóm 1

6.3. Nhóm 3: Bệnh tổn thương xương đa ổ hoặc vị trí đặc biệt

Điều trị bao gồm điều trị tấn công 6 tuần (điều trị tấn công đợt 2 chỉ cho những bệnh nhân bệnh dai dẳng hoặc tiến triển) và điều trị duy trì. Toàn bộ quá trình điều trị là 6 tháng. Phác đồ tương tự nhánh A của nhóm 1.

6.4. Điều trị hỗ trợ

- Sulphamethoxazole/trimethoprine: uống phòng nhiễm Pneumocystis carinii, 5 mg/kg/ngày của trimethoprine, 3 ngày/tuần. Truyền hồng cầu, tiểu cầu.

- G-CSF: dùng tĩnh mạch hoặc dưới da khi giảm bạch cầu trung tính kéo dài